头针联合口肌训练治疗儿童孤独症的效果及对患儿语言交流障碍、摄食行为的影响

陈 聪[1],陈荷光[2],李一凡[2],楼芯妤[2],矫金玲[1],张慧婷[1],吕玲玲[1]

(1.浙江中医药大学附属第三医院儿童康复科,浙江 杭州 310000;
2.浙江康复医疗中心中医康复科,浙江 杭州 310000)

摘要:目的 观察头针联合口肌训练治疗儿童孤独症(CA)的临床疗效及对患儿语言交流障碍、摄食行为的影响。**方法** 选取2022年5月至2023年3月于浙江中医药大学附属第三医院儿童康复科治疗的CA患儿78例,按照随机数字表法分为治疗组和对照组,各39例。对照组予口肌训练,治疗组在对照组治疗方法的基础上联合头针治疗。2组均治疗4个月后统计疗效。**结果** 治疗组的总有效率为92.31%(36/39),显著高于对照组的71.79%(28/39),2组比较,差异有统计学意义($P<0.05$)。治疗前2组的口部运动功能评分及摄食行为评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性;治疗后2组的口部运动功能评分均显著升高,摄食行为评分均显著降低,与同组治疗前比较,差异均有统计学意义($P<0.05$),且治疗组升高或降低更显著($P<0.05$)。治疗前2组的行为表现及功能发展评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性;治疗后2组上述评分均较同组治疗前显著升高,差异有统计学意义($P<0.05$),且治疗组升高更显著($P<0.05$)。治疗前2组的生活质量评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性;治疗后2组生活质量评分均较同组治疗前显著升高,差异有统计学意义($P<0.05$),且治疗组升高更显著($P<0.05$)。**结论** 头针联合口肌训练治疗儿童CA,可显著改善患儿语言表达及理解能力,纠正语言交流障碍,提高沟通及行为能力,有效改善摄食障碍问题,提高生活质量,且疗效显著,值得临床推广应用。

关键词:儿童;孤独症;头针;口肌训练;语言交流障碍;摄食行为;临床观察
中图分类号:R749.94 **文献标志码:**B **文章编号:**1673-4297(2025)02-0086-05
DOI:10.16840/j.issn1673-4297.2025.02.20

儿童孤独症(CA)为儿童中枢神经系统发育障碍性疾病,临床以狭隘兴趣、刻板行为、社会交往障碍、言语和非言语障碍为特征,若不能及时有效治疗,极易导致患儿丧失独立生活能力,给其家庭和社会带来沉重负担的同时,也严重影响其生活质量。目前临床治疗儿童CA常用方法较多,虽能一定程度改善患儿临床症状,但治疗手段单一,整体疗效欠佳[1]。研究发现[2-3],口部肌肉训练和感知训练治疗儿童CA疗效确切,可明显强化患儿口部运动机能,改善语言能力,而头针结合语言训练可明显提高CA患儿语言理解及表达能力。我们采用头针联合口肌训练治疗儿童CA,取得了满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年5月至2023年3月于浙江中医药大学附属第三医院儿童康复科治疗的CA患儿78例,按照随机数字表法分为治疗组和对照组,各39例。治疗组中男28例,女11例;年龄2~7岁,平均(4.98±0.61)岁;病程0.6~3年,平均(1.75±0.44)年。对照组中男24例,女15例;年龄3~7岁,平均(5.01±0.65)岁;病程0.8~3年,平均(1.83±0.49)年。2组的一般资料经统计学分析,差异均无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。本研究经浙江中医药大学附属第三医院医学伦理委员会批准。

1.2 诊断标准

参照《中国精神疾病分类与诊断标准(CCMD-3)》[4]中CA的诊断标准制定:有交流能力有质损害、社会交往有质损害表现,且兴趣狭窄、行为刻板,坚持生活方式与环境不变,且经儿童病史、生长发育史及精神检查确诊。

1.3 纳入标准

1)符合上述诊断标准;2)年龄2~7岁,病程≥6个

作者简介:陈聪(1994—),女,初级技师,理学学士。研究方向:儿童孤独症的康复治疗。
通信作者:陈荷光(1968—),女,主任中医师,医学学士,主要从事针刺治疗儿童神经系统疾病的临床工作。E-mail:zjjhchg@sina.com

中国知网 https://www.cnki.net

月，均为首次发病；3）近1个月内未曾接受任何相关治疗；4）有语言交流障碍及偏食、挑食等设施障碍行为；5）无精神疾病史，意识清晰，可坚持配合研究；6）患儿及家长知情，家长签署了知情同意书。

1.4 排除标准

1）合并精神发育迟缓者；2）既往有脑外伤史、神经系统疾病史及严重躯体疾病史者；3）合并结节性硬化病、多发性神经纤维瘤及各种代谢性疾病者；4）严重肝、肺、肾功能异常者；5）有出血倾向或凝血功能障碍者；6）严重晕针者；7）治疗期间接受其他方案治疗者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 予口肌训练。1）口周按摩：采用拇指指腹以顺时针方向按揉水沟、迎香及地仓穴，力度适宜，各穴位点按100次，按揉上唇肌肉3 min；以顺时针方向揉按翳风、下关、承浆及颊车穴，各穴位点按100次，再按揉患儿下唇肌肉、面颊各3 min；以顺时针方向按揉廉泉穴，并按摩患儿舌骨上下肌群、甲状舌骨肌，对捏上下唇肌肉，有利于上下唇被动接触发出音节，各3 min。2）口腔内肌肉按摩：针对高敏患儿以稳、慢手法按摩其脸颊、牙床区；针对低敏患儿以轻、快手法按摩其脸颊、牙床区，各3 min。3）口肌强化训练：利用蘸牛奶棉签或棒棒糖引导患儿舌头进行上下、左右摆动；利用棉签、奶瓶，采用手法技巧引导患儿进行砸唇、吮吸动作；将中指和示指指腹放置于患儿脸颊口腔内侧，配合拇指指腹旋转揉压，且引导患儿做出咀嚼动作。每次约30 min，每周6次，同时指导患儿进食时张口3 s，以强化下颌机能。

1.5.2 治疗组 在对照组治疗方法的基础上联合头针治疗。取穴：百会、四神聪、脑空、脑户、本神、神庭及舌三针（廉泉穴上1寸、廉泉穴左右各旁开0.8寸。操作方法：患儿取坐位，常规消毒穴位区域后，选取0.35 mm×25 mm一次性毫针（贵州安迪药械有限公司，批号160801），采用平刺方法以右手拇指、示指、中指三指协同快速捻转进针，深度0.5～0.8寸（约1～1.5 cm），得气后留针1 h，以患儿有重胀感或紧涩感为宜，每隔20 min行针1次，每日1次，每周5次。

2组均治疗4个月后统计疗效。

1.6 观察指标

1）临床疗效。疗效标准参照《儿童康复学》[6]制定。显效：临床症状与体征明显改善。有效：临床症状与体征有所缓解。无效：临床症状与体征无改变。总有效率=（显效例数+有效例数）/总例数×100%。

2）口部运动功能评分。治疗前后采用口部感觉-运动评估表[7]评估2组口部运动功能，包括舌运动（17条目，68分）、唇运动（8条目，32分）及下颌运动（9条目，36分）3个方面，共34个项目，每个项目0～4分，总分136分，分值越高，表示口腔运动功能越好。

3）摄食行为评分。治疗前后采用学龄前儿童饮食行为量表（PEBQ）[8]评估2组摄食行为情况，包括挑食（3.0分）、不良进食习惯（3.4分）、情绪性进食（2.0分）、食物响应（2.7分）、主动进食能力（4.2分）、外因性进食（3.4分）、过饱响应（3.2分），共7个维度，总分21.9分，分值越低，表示摄食障碍行为改善效果越好。

4）沟通和行为能力评分。采用《PEP-3自闭症儿童心理教育评估》[9]中的PEP-3量表评估2组患儿的沟通及行为能力，包括行为表现与功能发展2个维度，其中行为表现包括情感关系（12分）、游戏及兴趣（8分）、感觉反应（12分）、语言异常（11分），共43分；功能发展包括模仿（16分）、知觉（13分）、小肌肉（16分）、大肌肉（18分）、手眼协调（15分）、认知理解（26分）、认知表达（27分），共131分，分值越高，表示沟通和行为能力越好。

5）生活质量评分。采用儿童生活质量普通适用核心量表4.0（PedsQL4.0评分）[10]评估2组患儿的生活质量，包括生理功能、情感功能、学校表现、社会功能4个维度，每个维度以0～20分记，分值越高，表示生活质量越好。

1.7 统计方法

采用SPSS 22.0软件进行数据分析。计量资料以$\bar{x}\pm s$表示，组间比较采用独立样本t检验，组内比较采用配对样本t检验；计数资料以百分率表示，采用χ^2检验。$P<0.05$表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组临床疗效比较

治疗组的总有效率为92.31%（36/39），显著高于对照组的71.79%（28/39），2组比较，差异有统计学意义（$P<0.05$）。详见表1。

2.2 2组口部运动功能评分及摄食行为评分比较

治疗前2组的口部运动功能评分及摄食行为评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性；治疗后2组的口部运动功能评分均显著升高，摄食行为评分均显著降低，与同组治疗前比较，差异均有统计学意义（$P<0.05$），且治疗组升高或降低更显著（$P<0.05$）。详见表2。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 2组治疗前后沟通和行为能力评分比较

治疗前2组的行为表现及功能发展评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性；治疗后2组上述评分均较同组治疗前显著升高，差异有统计学意义（$P<0.05$），且治疗组升高更显著（$P<0.05$）。详见表3。

2.4 2组治疗前后生活质量评分比较

治疗前2组的生活质量评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性；治疗后2组生活质量评分均较同组治疗前显著升高，差异有统计学意义（$P<0.05$），且治疗组升高更显著（$P<0.05$）。详见表4。

表1 2组临床疗效比较 例（%）

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
对照组	39	12（30.77）	16（41.02）	11（28.21）	28（71.79）
治疗组	39	19（48.72）	17（43.59）	3（7.69）	36（92.31）*

注：与对照组比较*$P<0.05$。

表2 2组治疗前后口部运动功能评分及摄食行为评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	时间	口部运动功能	摄食行为
对照组	39	治疗前	50.08±7.03	15.12±3.10
		治疗后	79.62±10.47*	8.43±2.36*
治疗组	39	治疗前	48.85±8.78	14.86±3.05
		治疗后	96.83±12.26*△	5.74±1.88*△

注：与同组治疗前比较*$P<0.05$，与对照组治疗后比较△$P<0.05$。

表3 2组治疗前后沟通和行为能力评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	时间	行为表现	功能发展
对照组	39	治疗前	17.73±3.08	65.10±7.96
		治疗后	29.60±4.84*	95.67±10.55*
治疗组	39	治疗前	18.86±3.15	63.95±6.71
		治疗后	36.45±5.67*△	112.88±11.93*△

注：与同组治疗前比较*$P<0.05$，与对照组治疗后比较△$P<0.05$。

表4 2组治疗前后生活质量评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	时间	生理功能	情感功能	学校表现	社会功能
对照组	39	治疗前	8.14±1.87	7.97±2.15	6.68±1.71	8.03±1.41
		治疗后	12.04±2.05*	11.76±3.06*	10.01±2.78*	10.93±2.79*
治疗组	39	治疗前	8.08±2.13	8.23±2.85	6.62±1.67	7.69±1.45
		治疗后	15.35±3.96*△	15.94±3.63*△	14.36±3.19*△	14.12±3.70*△

注：与同组治疗前比较*$P<0.05$，与对照组治疗后比较△$P<0.05$。

3 讨论

西医学认为，CA患儿存在明显语言交流障碍，往往有语言发育障碍或迟缓，随年龄增长仍不见改善或表达性语言减少甚至消失，同时存在感觉异常、调节能力减弱等问题，有明显胃肠道问题及摄食障碍表现，极易导致患儿营养摄入不足，因此临床采取有效治疗手段以改善患儿语言表达及理解能力、改善摄食障碍问题已成为治疗儿童CA的重要环节，这也是有效提高患儿生活质量的关键[11-12]。

口肌训练通过训练患儿舌、唇、口等部位肌肉，可明显刺激患儿知觉，改善其口腔咽腭生理机能，增强其对口腔结构意识，提升语言表达及理解能力，同时口肌训练可明显调整患儿异常感觉，促进其感觉正常化，如给予口腔感知觉按摩，可帮助患儿培养正常饮食行为；唇部训练可提升患儿口腔各部运动协调性；下颌按摩训练，可提升患儿下颌感觉，减少乱咬东西的不良习惯等。但有研究发现，口肌训练属于条件反射的形成疗法，不具备主动性，因此单纯口肌训练难以从根本上解决问题[13]。近年来随着循证医学的发展及临床经验的积累，中医针刺在治疗儿童CA方面得到广泛应用，且效果显著[14]。

中医学中无儿童CA病名，根据其临床表现，可归属于“五迟”“语迟”“胎弱”等范畴。中医学认为本病的发生多因先天不足、后天失养、肾精亏虚、肝失

中国知网 https://www.cnki.net

条达、心窍不通，病位在脑，与心、肝、肾等脏器关系密切，治宜调节脏腑，疏通经络，平衡阴阳，醒脑安神，益智开窍。中医学认为，头为“诸阳之会”，脑为髓海，人体语言、行为均由脑主宰，刺激头部穴位可有效调节脏腑功能，疏通经络，运行气血。本研究以本神、神庭为主穴，醒脑开窍，镇静安神，其中本神穴属足少阳胆经，主治神明相关病证，神庭穴属督脉，主治神志有关病证。百会为“三阳五会”，四神聪为经外奇穴，二者配伍可振奋阳气，醒脑开窍，镇静安神。脑空属足少阳胆经，可平肝潜阳，疏泄肝胆之气机；脑户属督脉，可醒脑调神；舌三针可醒神通脑，利咽生津。诸穴合用，共奏醒脑开窍、清利头目、益智开窍、镇静安神之功效。行针采取平刺手法有益精填髓、养心安神之功效。

综上所述，头针联合口肌训练治疗儿童CA，可显著改善患儿语言表达及理解能力，纠正语言交流障碍，提高沟通及行为能力，有效改善摄食障碍问题，提高生活质量，且疗效显著，值得临床推广应用。

参考文献：

[1]施茜馨，王军，闫海虹，等.益肾豁痰汤加减治疗儿童孤独症谱系障碍精亏痰扰证35例临床观察[J].中医儿科杂志，2022，18(5)：47-51.
[2]肖恋.口部肌肉训练和感知训练治疗孤独症儿童语言交流障碍的疗效观察[J].医学食疗与健康，2021，19(10)：209-210.
[3]梁亚眉，缪英英，赵佳佳，等.头针结合语言训练对孤独症儿童语言康复的临床观察[J].中医儿科杂志，2019，15(3)：71-74.
[4]中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准(CCMD-3)[M].3版.济南：山东科学技术出版社，2001：75.
[5]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].北京：中国医药科技出版社，2012：11.
[6]李晓捷.儿童康复学[M].北京：人民卫生出版社，2018：188.
[7]潘雪珂.口部感觉-运动评估表的编制及其在脑瘫儿童中的应用[D].上海：华东师范大学，2017.
[8]杨显君，江逊，张玉海，等.学龄前儿童饮食行为量表的编制与评价[J].中国儿童保健杂志，2012，20(8)：682-685.
[9]于松梅.心理教育量表(PEP)中文版临床应用比较——基于内地C-PEP-3与香港PEP-3的思考[J].绥化学院学报，2021，41(10)：125-129.
[10]王慎玉，甘正凯，胡晓松，等.儿童生命质量测定量表用于流感儿童评价的信度和效度研究[J].预防医学，2020，32(5)：471-474.
[11]朱俊丽，姜志梅，聂颖，等.针药结合奖励法语言训练对孤独症语言障碍的改善效果研究[J].中华中医药学刊，2021，39(10)：195-198.
[12]刘杰，董萍，王怡，等.孤独症儿童饮食行为问题及相关干预[J].中国儿童保健杂志，2020，28(1)：6-9，14.
[13]张晓宇，吕梦丹，尚清.口部肌肉按摩联合感知训练治疗孤独症儿童语言交流障碍的临床价值分析[J].四川解剖学杂志，2019，27(1)：82-83.
[14]贾永男，顾建辉，景玉珍，等.近5年针刺治疗儿童孤独症谱系障碍临床研究进展[J].中医儿科杂志，2022，18(2)：97-101.

(2023-11-01收稿；2024-11-14修回)
[编辑：牟德海]

The therapeutic effect of scalp acupuncture combined with oral muscle training on childhood autism and its impact on language communication disorders and feeding behavior in children

CHEN Cong[1], CHEN Heguang[2], LI Yifan[2], LOU Xinyu[2], JIAO Jinling[1], ZHANG Huiting[1], LYV Lingling[1]

(1. Department of Child Rehabilitation, No.3 Affiliated Hospital of Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou, Zhejiang, 310000, China; 2. Traditional Chinese Medicine Rehabilitation Department, Zhejiang Rehabilitation Medical Center, Hangzhou, Zhejiang, 310000, China)

Abstract: Objective To observe the clinical efficacy of scalp acupuncture combined with oral muscle training in the treatment of childhood autism (CA) and its impact on language communication disorders and feeding behavior in children. **Methods** 78 children with CA admitted to Child Rehabilitation Department of No.3 Affiliated Hospital of Zhejiang Chinese Medical University from May 2022 to March 2023 were randomly divided into a treatment group and a control group, with 39 cases in each group. The control group received oral muscle training, while the treatment group received scalp acupuncture combined with oral muscle training. After 4 months of continuous treatment, the clinical efficacy of both groups was evaluated. **Results** After treatment, the total effective rate of the treatment group 92.31% (36/39) was significantly higher than that of the control group 71.79% (28/39) ($P<0.05$); Before treatment, there was no significant difference in the scores of oral motor function and feeding behavior between the two groups ($P>0.05$). After treatment, the scores of oral

中国知网 https://www.cnki.net

motor function in the two groups were significantly improved ($P<0.05$), and the treatment group was higher than the control group ($P<0.05$); After treatment, the feeding behavior scores of the two groups significantly decreased ($P<0.05$), and the treatment group was lower than the control group ($P<0.05$); Before treatment, there was no significant difference in the PEP-3 score and PedsQL4.0 score between the two groups ($P>0.05$). After treatment, the above scores in the two groups were significantly improved ($P<0.05$), and the treatment group was higher than the control group ($P<0.05$). **Conclusion** The combination of scalp acupuncture and oral muscle training has a definite therapeutic effect on children with CA, which can significantly enhance their oral motor function, correct their language communication disorders, enhance their communicative and behavinal skills improve their feeding behavior, and improve their quality of life. It's worthy of olinical promotion and application with its remarkable curative effect.

Keywords: children; autism; scalp acupuncture; mouth muscle training; language communication barriers; feeding behavior;clinical observation

中国知网 https://www.cnki.net